

COLONOSCOPIA

Carmen Villar Lucas, Raisa Quiñones Castro, Agustín Herrera Abián.

INTRODUCCIÓN

Qué es

La colonoscopia es una técnica que permite la visualización directa de la mucosa del colon, desde recto hasta íleon terminal, permitiendo realizar diagnóstico y terapéutica. En ocasiones se realiza solo rectosigmoidoscopia, explorándose solo estos segmentos intestinales.

Procedimiento

El colonoscopio es un tubo flexible de 170 cm que se introduce por el recto y que consta de una óptica, una luz y un canal de trabajo.

Preparación: Para que sea posible una correcta visualización de la mucosa intestinal es imprescindible que la limpieza sea adecuada, por lo que el paciente deberá realizar una buena preparación del colon.

Dieta líquida los 2-3 días antes (varía según centros hospitalarios)

Soluciones con polietilenglicol (Solución evacuante Bohn®): 8 litros divididos en dos dosis: el día antes y 4 horas antes de la prueba. Si la colonoscopia es por la mañana: 12 sobres en 3 litros de agua, se comienza a beber la tarde antes de la prueba, y 4 sobres en 1 litro 4 horas antes de la prueba. Si la prueba se realiza por la tarde, empezar a tomar toda la preparación 8 horas antes de la prueba.

Productos basados en el picosulfato sódico (Citrafleet®): esta preparación se realiza en dos tomas que se adaptan a la hora de su colonoscopia. Cada toma consiste en beber un sobre de Citrafleet® disuelto en un vaso de agua, teniendo que tomar a continuación al menos 2 litros de los líquidos claros permitidos). En caso de estreñimiento, antes de cada toma se recomienda ingerir 2 comprimidos de Bisacodilo (Dulcolaxo®). - Si la exploración se realiza por la mañana: la Toma 1 se realiza a las 17 horas (5 p.m.) y la Toma 2 a las 23:30 horas (11:30 p.m.) del día anterior a la prueba. - Si se realiza por la tarde: la Toma 1 se realiza a las 20 horas (8 p.m.) del día anterior a la prueba y la Toma 2 a las 10 horas (10:00 a.m.) del mismo día de la endoscopia.

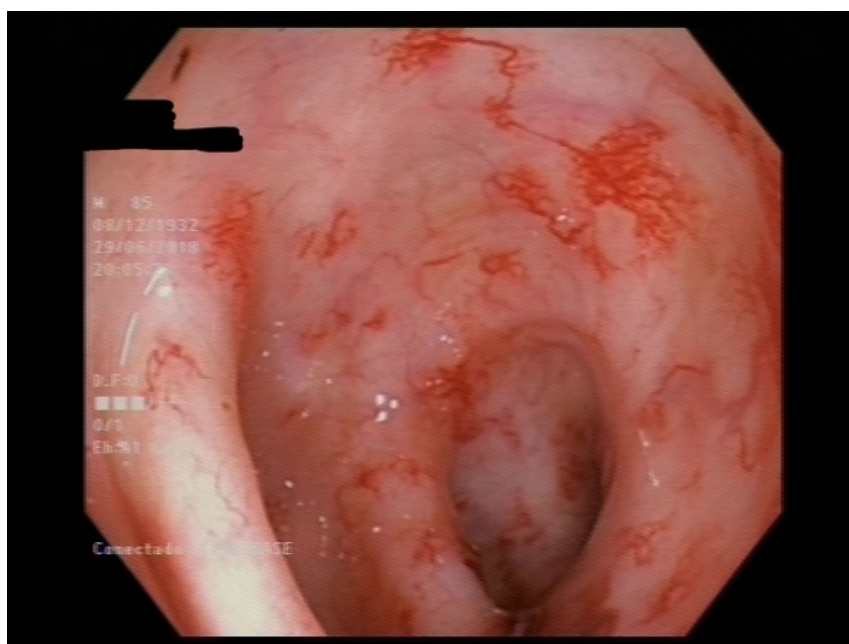
Productos basados en el macrogol o de bajo volumen (Moviprep®): esta preparación se realiza en dos tomas que se adaptan a la hora de su colonoscopia. Cada toma consiste en mezclar el contenido de un sobre A y un sobre B en un litro de agua que se debe beber a lo largo de 1-2 horas, intentando tomar un vaso completo al menos cada 15 minutos. Posteriormente debe beber al menos 1 litro de los líquidos claros permitidos. Si la exploración se realiza por la mañana: la Toma 1 se realiza a las 17 horas (5 p.m.) y la Toma 2 a las 23:30 horas (11:30 p.m.) del día anterior a la prueba. Si se realiza por la tarde: la Toma 1 se realiza a las 20 horas (8 p.m.) del día anterior a la prueba y la Toma 2 a las 10 horas (10:00 a.m.) del mismo día de la endoscopia.

El médico prescriptor de la prueba deberá tener en cuenta que pacientes con situaciones especiales como insuficiencia renal o cardíaca pueden requerir ajuste de esta preparación.

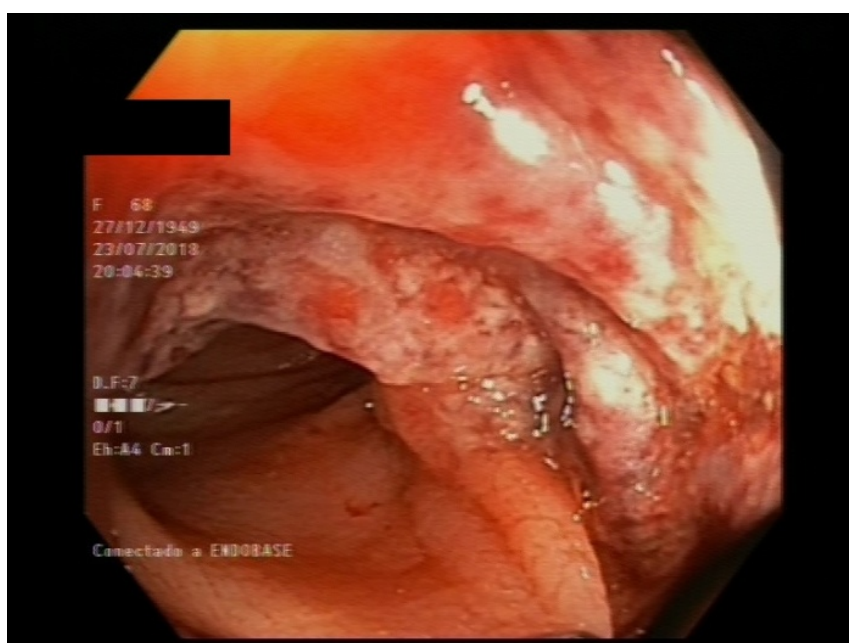
Previamente a la realización de esta prueba el paciente debe ser debidamente informado del procedimiento, la indicación y las posibles complicaciones, firmando un consentimiento informado por escrito. Se deberá tener precaución con el uso de antiagregantes y anticoagulantes (ver tabla en el capítulo de Gastroscofia)

Actualmente la mayoría de las colonoscopias se realizan con sedación, por lo que se recomienda acudir con un acompañante y evitar conducir o beber alcohol tras la prueba.

INDICACIONES	CONTRAINDICACIONES
Hemorragia digestiva baja Diarrea crónica Sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal Seguimiento para diagnóstico precoz de cáncer de colon en enfermedad inflamatoria intestinal y síndromes de poliposis familiar Terapéutica: extirpación de pólipos, extracción de cuerpo extraño, descompresión de vólvulo de colon o megacolon tóxico, hemostasia (clip, cauterización...), cecostomía percutánea, dilatación de estenosis, colocación de prótesis...	Perforación colónica Peritonitis Fallo cardiorrespiratorio agudo IAM reciente Cirugía colónica reciente Aneurisma abdominal de gran tamaño o en sus ramas Diverticulitis (relativa)



Proctitis actínica



Complicaciones

- Perforación colónica (más frecuente si se realiza terapéutica, si existe diverticulosis severa...)
- Bacteriemia (por ello los pacientes con alto riesgo de endocarditis requieren profilaxis)
- Dolor abdominal por exceso de insuflación
- Hemorragia postpolipectomía (asociada al tamaño del pólipo y el uso de antiagregantes y anticoagulantes)
- Síndrome postpolipectomía (dolor y fiebre sin perforación)

BIBLIOGRAFÍA

- Gastrointestinal endoscopy in practise. Chapter: Diagnostic colonoscopy. Jean Mark Canard, Jean-Christophe Létard, Ian Penman
- Phenninger and Fowler's procedures for primary care. Chapter 100. 685-689. John Bartels Pope
- Documento de consentimiento informado para colonoscopia de la UED del Hospital Universitario de La Princesa. Revisado: Dr. J.A. Moreno Monteagudo Responsable de la UED y Responsable de Calidad Dr. C. Santander Vaquero Jefe de Servicio de Aparato Digestivo